

경 고 사 항

1. 제 목 : 진료수가 관리 업무 부적정
2. 관계기관 : ☆☆☆☆병원
3. 내 용 : ☆☆☆☆병원에서는 국가유공자 및 지역주민에게 의료서비스를 제공하고 보건복지부 및 보훈처 고시에 따라 행위별 진료수가에 따른 진료비를 산정하여 [표 1]과 같이 '17년 558억 원 상당의 진료수익을 실현하였습니다.

[표 1] 2017년 진료실적

(단위:천명/백만원)

구분	입원			외래			계		
	국비	사비	계	국비	사비	계	국비	사비	계
금액	19,311	7,307	26,618	22,493	6,696	29,189	41,804	14,003	55,807

가. 위탁검사 단가 관리

☆☆☆☆병원에서는 국가유공자 및 지역주민의 질병 진단을 위해 혈액 등으로 진단검사를 실시하고 있으며, 일정 수량 미달하는 검사 처방에 대해서는 인력 및 장비 운영의 효율성을 감안하여 [표 2]과 같이 외부 전문기관으로 검사를 위탁 의뢰하고 있습니다.

[표 2] 2017년 진단 및 병리 검사 위탁의뢰 실적

(단위:종/건/천원)

구 분	검사항목	건수	금액	의뢰기관
진단검사	178	8,300	###,###	%%%%%%%%%
병리검사	24	5,045	##,###	%%%%%%%%%

「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여상대가치점수」 제1편 제2부 제2장 검사료의 산정지침에 따르면 인체에서 채취한 가검물에 대한 검사를 “(부록) 검체검사 위탁에 관한 기준”에서 정한 위탁기관으로 위탁하는 경우에는 제2장 제1절(검체검사료) 및 제2절(병리검사료) 분류항목 소정점수(가감률 적용 포함)에 위탁기관의 점수당 단가를 곱하여 계산한 금액의 10%를 “위탁검사관리료”로 산정하도록 명시되어 있습니다.

[표 3] 상대가치 점수당 단가 현황

(단위:원)

구 분	2018년	2017년
「의료법」 제3조제2항제3호에 따른 의료기관 중 병원, 요양병원, 종합병원	73.5	72.3
「의료법」 제3조제2항제3호에 따른 의료기관 중 의원	81.4	79.0

이에 따라 ☆☆☆☆병원에서는 통합EMR시스템의 수가관리프로그램에서 위탁검사에 대해서 위탁기관의 상대가치 점수당 단가를 별도로 관리할 수 있도록 입력칸을 만들고 산정지침대로 자동계산이 될 수 있도록 운영하고 있습니다.

따라서 ☆☆☆☆병원에서는 위탁검사에 대한 정기적 처방 실적을 확인하여 자체검사 전환 등을 검토하고 산정지침에 따라 위탁기관의 종별에 따라 상대가치 점수당 단가를 철저히 관리하여 적정 검사료를 산정하여 병원에 손실이 발생하지 않도록 관리하여야 합니다.

그런데, ☆☆☆☆병원 위탁검사 수납 및 청구내역을 확인한 결과, 알츠하이머 병이나 관상동맥질환의 발병 가능성을 추정하기 위한 Apo E Genotyping검사(유전성질환 유전자검사)를 병원 자체검사로 실시할 수 없어 %%%%(의원급)에 위탁의뢰하여 검사를 실시하는데, 2018. 1. 1. 점수당 단가를 81.4원으로 변경하지 않아 2017년 점수당 단가인 79.0원으로 계산되어 [표 4]과 같이 총 114건, ###천 원 상당이 착오 수납된 것으로 확인되었습니다.

[표 4] 위탁검사 수납 착오 내역

(단위:원)

수가코드	수가명	처방수량	수납금액	정상금액	착오금액
LWCX572006	Apo E Genotyping(유전성질환유전자검사)	114	#,###,###	#,###,###	###,###

나. 국비진료비 가산 수가 관리

「보훈병원 의료수가 기준(보훈처 고시 제2017-8호, '17.12.11.)」 제6조(행위료 가산)에 따르면 전상군경 등 진료대상자에게는 행위료에 대하여 28퍼센트를 가산(“이하 국비가산”이라 한다.)하여 산정한다. 다만, 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여상대가치점수」 제1편 제2부 제1장, 제17장부터 제19장까지를 제외한 행위료 중 종별가산율¹⁾ 미적용 수가는 적용하지 아니하는 것으로 명시되어 있습니다.

이에 따라 보훈병원에서는 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여상대가치점수」의 내역에 따라 통합EMR시스템으로 각 행위별로 코드화(이하 ‘수가’라 한다.) 하여 「보훈병원 의료수가 기준」을 근거로 국비가산 여부 항목을 만들어 자동으로 가산하여 진료비가 산정되도록 운영하고 있습니다.

따라서 ☆☆☆☆병원에서는 보훈처 및 보건복지부 고시 등의 변경에 따라 수가가 변경할 경우 국비가산 여부를 점검하여 부당한 진료비가 산정되지 않도록 관리하여야 합니다.

1) 종별가산율

- 상급종합병원, 상급종합병원에 설치된 치과대학 부속 치과병원 등 : 30%
- 상급종합병원을 제외한 종합병원, 상급종합병원에 설치된 경우를 제외한 치과대학 부속 치과병원 등 : 25%
- 병원, 치과병원, 한방병원, 요양병원 : 20%
- 의원, 치과의원, 한의원, 보건의료원 : 15%

그런데, 2017년~2018년 4월까지 수가별 수납금액을 확인한 결과, 「보훈병원 의료수가 기준(제2016-5호, '16. 6.22.)」이 '16. 7. 1.부터「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여상대가치점수」 제1편 제2부 제1장, 제17장부터 제19장까지를 제외한 행위로 중 중별가산을 미적용수가는 적용하지 아니한다고 개정되어 전혈 및 혈액성분제제료에 대하여 국비가산이 폐지된 것을 인지하였음에도 [표 5]와 같이 통합EMR의 수가관리에 국비가산 여부 항목의 체크부분을 감사일 현재('18.5.16)까지 삭제하지 않아 적혈구 농축액 400cc 등 4개 항목의 수가에 대해 2,033개, ##,###천 원 상당이 국비가산으로 수입에 반영된 사실이 확인이 되었습니다.

다만, 건강보험심사평가원(이하 “심평원”이라 한다.)으로 국비정산진료비에 심사를 의뢰하여 심평원에서 삭감액으로 조정되는 것이 확인되었지만, 국비정산진료비의 청구가 평균 6개월 정도 지연되는 것을 감안한다면 지속적으로 6개월 이상 평균 #백만 원 상당 수입을 과다 계상되고 있었습니다.

[표 5] 전혈 및 혈액성분제제료 국비 가산 산정 착오 현황

(단위:개/원)

수가코드	수가명	처방년월	보험단가	국비수가	차액	처방수량	착오금액
BX2022	적혈구 농축액 400cc	2016.7~12	##,###	##,###	##,###	311	#,###,###
		2017	##,###	##,###	##,###	594	#,###,###
		2018.1~5.16	##,###	##,###	##,###	223	#,###,###
BX2042	신선동결혈장 400cc	2016.7~12	##,###	##,###	##,###	14	###,###
		2017	##,###	##,###	##,###	46	###,###
		2018.1~5.16	##,###	##,###	##,###	28	###,###
BX2081	혈소판 농축액 320cc	2016.7~12	##,###	##,###	##,###	20	###,###
		2017	##,###	##,###	##,###	45	###,###
BX2082	혈소판 농축액 400cc	2016.7~12	##,###	##,###	##,###	333	#,###,###
		2017	##,###	##,###	##,###	363	#,###,###
		2018.1~5.16	##,###	##,###	##,###	56	###,###
합 계						2,033	##,###,###

4. 조치할 사항

○ ☆☆☆☆병원장은

- 보건복지부 및 보훈처 고시에 의해 수가를 변경한 경우 시행 전에 전체적으로 변경내역에 대하여 재확인하여 변경사항이 착오 또는 누락되지 않도록 하여 진료비가 착오산정 되지 않도록 관리하여 주시기 바라며,(권고)
- 향후 동일사례가 발생하지 않도록 “가”사항과 관련자에게 「경고」, “나”사항 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(경고, 주의)